

Р.М. Рамазанова

«ЛимФорум» в Казахстане

13–14 мая 2016 г. в Алматы состоялся интерактивный научно-практический форум с международным участием «ЛимФорум Казахстана». Это мероприятие уже второй год подряд является важной площадкой для обмена опытом, как среди казахстанских, так и зарубежных специалистов. Одним из наиболее ожидаемых событий в рамках форума стало обсуждение единых для стран СНГ протоколов лечения лимфопролиферативных заболеваний и статуса внедрения Единой информационной системы «Лимфопротиферативные заболевания», для регистрации, краткосрочного и долгосрочного ведения больных лимфомами, а также анализа данных об этой группе заболеваний в различных регионах Казахстана.

В мероприятии приняли участие более 50 ведущих патоморфологов, онкологов и гематологов Северо-Западного, Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов России, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей Казахстана, городов Алматы и Астаны, из них более половины докторов и кандидатов медицинских наук. На форуме присутствовали представители более 10 медицинских ВУЗов России и Казахстана.

Работу форума открыла Президент Общественного Фонда «Казахстанское профессиональное общество онкогематологов», профессор кафедры онкологии, гематологии Казахского Медицинского Университета непрерывного образования, доктор медицинских наук, Рамазанова Райгуль Муханбетовна.

В своем вступительном слове председатель ЛимФорума член-корреспондент РАМН, профессор, проректор по учебной работе и международному сотрудничеству, зав. кафедрой онкологии Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ, Россия, Председатель Российского общества онкогематологов Ирина Владимировна Поддубная подчеркнула, что одним из ключевых аспектов, лежащих в основе адекватного ведения больных и позволяющих достичь основной цели – увеличения продолжительности жизни больного, является взаимопонимание и сотрудничество клинициста и патоморфолога.

Нередко клиническая информация обладает не меньшим значением для диагностов, чем морфологические исследования – для клиницистов. Для подтверждения этих тезисов экспертами-патоморфологами были представлены случаи сложности клинко-морфологической диагностики, в которых было продемонстрировано и подчеркнуто значение взаимодействия врача-клинициста и врача-патоморфолога для правильной постановки диагноза и для выбора адекватной тактики лечения больного. Традиционно для участия в ЛимФоруме врачи разных регионов России, Белоруссии, Армении и Казахстана предварительно представляли интересные, сложные и спорные клинические случаи, из которых Экспертным советом было выбрано 10 наиболее показательных случаев из Астаны, Алматы, Шымкента, Самары и Казани. Данные доклады затронули широкий спектр вопросов ведения больных с различными лимфопротиферативными заболеваниями.

В своем докладе «Пути и перспективы развития онкогематологической службы Казахстана» Р.М. Рамазанова подробно остановилась на новых и актуальных вопросах этой тематики.

Заболеваемость лимфомами не так высока, как заболеваемость раком легкого, желудка и молочной железы. При этом 5-летняя общая выживаемость (ОВ) превышает данный показатель при многих локализациях и составляет в Казахстане 48,8%. Это связано с внедрением современных методов диагностики лимфом, а также лечение в соответствии с международными протоколами с применением таргетных препаратов. Динамика выживаемости имеет тенденцию к росту как в мире в целом, так и в Казахстане в частности, и за последние 30 лет увеличилась в 2 раза. В КазНИИОиР в настоящее время возможно проведение широкого спектра диагностических исследований: иммуногистохимического, иммунофенотипирования лимфоцитов периферической крови и костного мозга, молекулярно-генетического исследования, компьютерной томографии (КТ), создан Республиканский морфологический референс центр на базе патологоанатомической и молекулярно-генетической лабораторий.

Отмечается важность иммуногистохимической диагностики и определения подтипов неходжкинских лимфом, поскольку, несмотря на общий прогресс в лечении данных групп пациентов, установлено, что они отличаются по выживаемости в зависимости от гистологических подтипов. Значит, необходимы новые прогностические маркеры и терапевтические стратегии для данных групп пациентов.

В классификации новообразований лимфоидной ткани Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среди В-клеточных лимфом выделяют новые подтипы: В-клеточная лимфома неклассифицированная с фенотипом, промежуточным между ДВККЛ и лимфомой Беркитта, и В-клеточная лимфома неклассифицированная с фенотипом, промежуточным между ДВККЛ и классической ЛХ; среди Т-клеточных лимфом выделяют новые подтипы: анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-позитивная и анапластическая крупноклеточная лимфома, ALK-негативная.

Следует также отметить недавнее появление в международных стандартах рекомендаций относительно использования ПЭТ-исследования (ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография) при стадировании и финальной оценке эффективности терапии лимфом. Но КТ остается стандартом при промежуточной оценке эффективности терапии и наблюдении. Последнее время все чаще обсуждается возможность исключения процедуры биопсии костного мозга из алгоритма обследования при проведении ПЭТ, однако, биопсия костного мозга – по-прежнему стандарт обследования. При лимфомах возможна оценка регрессии опухоли по шкале Δ SUV и Deauville. В настоящее время результат ПЭТ Deauville 3 отнесен к негативному. Широко используются и новые метаболические биомаркеры: MTV (metabolic tumor volume), TLG (total lesion glycolysis).

Согласно данным Национального канцер-регистра 2014 г., максимальный уровень заболеваемости неходжкинскими лимфомами отмечен в возрастной группе 70–74 лет и составил 15,1 на 100 тыс. При этом не получали специального лечения 21% первичных больных неходжкинской лимфомой, из них 67% — это больные старше 60 лет. Проблемы, с которыми сталкивается специалист при лечении пациентов этой категории, — коморбидность (у 70% больных отмечается наличие сопутствующей патологии) и высокая токсичность химиотерапии (ХТ). Согласно рекомендациям ESMO и NCCN, пациентам в возрасте до 80 лет рекомендовано проведение 8 курсов R-CHOP-21 или 8 курсов R + 6 CHOP-14; пациентам старше 80 лет рекомендовано курсы полихимиотерапии (ПХТ) R-miniCHOP, возможно исключение доксорубина из схем терапии, замена доксорубина на этопозид, липосомальный доксорубин.

Вторичное поражение центральной нервной системы (ЦНС) отмечено в 1–9% (чаще 3–5%) случаев, возникает чаще во время лечения или в течение 6 мес после его окончания. Согласно ESMO, факторами риска являются: более 1 Е, повышение содержания лактатдегидрогеназы (ЛДГ); согласно NCCN: поражение параназальных синусов, яичка, эпидуральное образование, поражение костного мозга, наличие ВИЧ, более 1 Е, повышение ЛДГ. Для профилактики поражения ЦНС может применяться курс высокодозного метотрексата 3,5 г/м² внутривенно (в/в) после окончания терапии 1-й линии.

Т-клеточные лимфомы составляют 10% всех неходжкинских лимфом (ВОЗ), имеют более агрессивное течение и плохой прогноз по сравнению с В-клеточными лимфомами, поэтому отсутствуют единые стандарты их лечения.

В своем докладе Р. М. Рамазанова остановилась также на особенностях диагностики и лечения экстранодальных лимфом (первичная лимфома ЦНС, лимфома яичка, первичная медиастинальная лимфома).

Первичная лимфома ЦНС составляет 1% всех лимфом, 1% — опухолей мозга, 5% — всех ВИЧ-ассоциированных лимфом, гистологически примерно в 90% случаев это ДВБКЛ. У 95% пациентов выявляют поражение полушария головного мозга, глаза — у 30–40%, чаще — у лиц пожилого возраста. Стандартная ХТ (CHOP-like режимы) в лечении лимфом ЦНС неэффективна. В настоящее время стандартом терапии является метотрексат в дозе 3,5 г/м² (создает необходимую концентрацию в ткани головного мозга и ликворе); улучшения результатов можно достичь добавлением четырех введений Ага-С 2 г/м², при этом 5-летняя ОВ пациентов достигает 30%. Лучевую терапию (ЛТ) на зону головного мозга проводят в суммарной очаговой дозе (СОД) 36 Гр. Ее следует избегать у лиц пожилого возраста в связи с высокой нейротоксичностью (5-летняя ОВ <20%).

Медиастинальная лимфома составляет 2–3% от всех лимфом, характеризуется большим объемом опухолевой массы в переднем средостении, диагностируется преимущественно у женщин в возрасте 30–40 лет, иммунофенотип опухолевых клеток подобен классической ЛХ. При лечении медиастинальной лимфомы используются курсы ПХТ по схемам R-CHOP, R-MACOP-B, DA-EPOCH-R. Роль ЛТ в настоящий момент не определена, для ее изучения недавно начаты исследования IELSG-26 (изучают роль ПЭТ/КТ без применения ЛТ) и IELSG-37 (исследование целесообразности использования ЛТ у ПЭТ-пациентов).

У пациентов с индолентными лимфомами и наличием гепатита С противовирусная терапия должна быть терапией 1-й линии. При MALT-лимфоме с поражением глаз доказанным этиологическим фактором является наличие *Chlamydia psittaci*. Лечение состоит в антибактериальной терапии — монотерапии доксициклином. При MALT-лимфоме желудка определение лечебной тактики зависит от стадии заболевания и инфицирования *Helicobacter pylori*. При I и II стадиях с наличием *H. pylori* проводят ее эрадикацию с реоценкой при фиброгастродуоденоскопии и контролем через 3 мес, при I и II стадиях и отсутствии *H. pylori* рекомендована ЛТ, монотерапия ритуксимабом. При III–IV стадиях проводят стандартные курсы ПХТ.

Продолжила конференцию профессор Елена Андреевна Демина, д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАН, Россия с докладом по лечению пациентов с ЛХ. Первый доклад «Последние достижения в области лечения ЛХ» профессор начала с напоминания определения разных групп пациентов с ЛХ. Так, в раннюю благоприятную группу пациентов включены больные с I–II стадиями без факторов неблагоприятного прогноза, в раннюю неблагоприятную (промежуточную) группу — пациенты с I–II стадиями с наличием факторов неблагоприятного прогноза, в группу распространенного заболевания — пациенты с III–IV стадиями, а также некоторые больные со стадией IIB.

Далее докладчик перешла к описанию лечения пациентов с ранними благоприятными стадиями. Золотым стандартом терапии этой группы больных является проведение ХТ по схеме ABVD и ЛТ. Однако количество курсов ХТ и доза ЛТ некоторое время являлись предметом дискуссий. Ответ на вопрос об оптимальной комбинации химиолучевой терапии дало исследование HD10 GHSG (2010). Его результаты не продемонстрировали достоверных отличий среди 4 групп пациентов, получавших различную терапию (2 ABVD vs 4 ABVD, 30 Гр vs 20 Гр). Таким образом, стандартом терапии для данной группы больных ЛХ является проведение 2 курсов ХТ по схеме ABVD и ЛТ на вовлеченные зоны в СОД 20 Гр. Позже ученые попытались провести еще большую деэскалацию терапии, изъяв из схемы ABVD один или два препарата. Так, в исследовании HD13 (2013) сравнивали 4 режима терапии: 2 ABVD + ЛТ, 2 AVD + ЛТ, 2 ABV + ЛТ, 2 AV + ЛТ. Однако, невзирая на менее выраженные проявления токсичности, ни один из этих курсов терапии не оказался столь же эффективным, как курсы ABVD. Еще одно исследование группы GHSG посвящено роли ПЭТ в определении тактики терапии больных ЛХ. В исследовании HD16 пациентов рандомизировали на группу стандартной терапии (2 ABVD + ЛТ, независимо от результатов ПЭТ) и экспериментальную группу (после проведения 2 курсов ABVD пациенты были разделены на основании результатов ПЭТ-исследования на группу наблюдения — при ПЭТ-отрицательном результате и группу ЛТ — при ПЭТ-положительном результате).

В промежуточной группе используется более интенсивный подход к терапии. Так, в исследовании HD11 (2010) проведено сравнение 4 курсов ABVD и BEACOPP с ЛТ в дозе 20 или 30 Гр. Выявлено, что наихудшие результаты достигнуты в группе пациентов, получившей наименее токсичное лечение (4 ABVD + 20 Гр). В исследовании HD14 сравнивали 2 терапевтических стратегии: 4 ABVD + 30 Гр vs 2 BEACOPPesc + 2 ABVD + 30 Гр (2+2).

Наилучшие результаты отмечены в группе пациентов, получивших терапию «2+2». Для этой группы больных также продолжаются попытки избежать ЛТ или снизить ее интенсивность на основании результатов ПЭТ. В частности, в исследовании HD17 GHSG у пациентов после проведения ХТ в объеме 2 BEACOPPesc + 2 ABVD проводили ПЭТ-исследование. ПЭТ-отрицательные пациенты были рандомизированы для проведения ЛТ или наблюдения. В группе ПЭТ-положительных больных рандомизацию выполняли для применения ЛТ на вовлеченные зоны или узлы. Результаты исследования ожидаются.

Следующую часть своего доклада профессор Е.Демина посвятила выбору терапии, основанному на результатах ПЭТ. В исследование UK NCRI RAPID были включены пациенты с ранними стадиями ЛХ, получившие 3 курса ХТ по схеме ABVD. По данным ПЭТ их разделили для проведения ЛТ или наблюдения. Достоверных отличий в результатах лечения в обеих группах не выявлено.

Посвятив следующую часть доклада роли ПЭТ-КТ в диагностике лимфом, эксперт подчеркнула и обосновала преимущества данного метода диагностики, объединяющего специфичность КТ и чувствительность ПЭТ. В связи с этим ПЭТ-КТ позволяет учитывать и анатомические данные, и витальность опухолевых клеток. ПЭТ-КТ является золотым стандартом в диагностике лимфом и позволяет более точно определить стадию заболевания.

Ссылаясь на данные Hutchings (2012), Cerci (2009) и Rigacci (2007), докладчик подчеркнула, что у 10–15% пациентов с ЛХ при проведении ПЭТ-КТ стадия заболевания оказывается более поздней и очень редко смещается в сторону ранней. Надежнее этот метод исследования оказался при определении поражения костного мозга (выявлено у 18% пациентов путем проведения ПЭТ-КТ по сравнению с 6% — при выполнении биопсии).

В отношении агрессивных лимфом (мантийно-клеточная, ДВККЛ, фолликулярная Grade 3, анапластическая крупноклеточная) ПЭТ-КТ также продемонстрировала: высокую чувствительность (>90%), специфичность (при поражениях костного мозга, селезенки, легких, печени), выявление очагов, невыявленных при КТ и, как следствие, повышение стадии заболевания (>20%).

При фолликулярной лимфоме (ФЛ) после проведения ПЭТ-КТ 60% пациентов с исходно ранней (I–II) стадией в последующем имеют распространенную (III–IV) стадию. В отличие от предыдущих данных, в этом случае возможность выявления поражения костного мозга ограничена (до сих пор стоит полагаться на биопсию как на основной метод). Автор также обратила внимание на то, что при ФЛ прогностическая роль ПЭТ-КТ превышает таковую при использовании FLIPI.

Профессор Е. Демина резюмировала, что при фокальном поражении костного мозга (при ЛХ, лимфоме Беркитта, ДВККЛ) более точным следует считать ПЭТ-КТ, а при диффузном (преимущественно при индолентных лимфомах) — трепанобиопсию.

Докладчик отдельно остановилась на понятии стандартизованного накопления (SUV) и Δ SUV, а также на относительно новых показателях — метаболическом объеме опухоли (MTV) и тотальном гликолизе опухоли (TLG), а также их роли в прогнозе течения заболевания. Отдельно было выделено «количественный анализ ПЭТ» и изучение в рамках международных исследований его роли в комбинации с биомаркерами, которые

интегрированы в прогностическую модель для прогнозирования отдаленных результатов лечения. Яркий пример был приведен относительно ЛХ — новая возможность риск-стратификации пациентов по промежуточному ПЭТ-КТ и некоторым биомаркерам.

Далее докладчик рассказала о перспективных направлениях в лечении ЛХ. В числе новых препаратов, которые могут быть использованы в терапии, — брентуксимаб ведотин, биспецифическое МкАТ (AFM16), анти-CD20 МкАТ, эверолимус, руксолитиниб, ибрутиниб, ниволумаб. Появление МкАТ против CD30 антигена (брентуксимаб ведотин, SGN35) кардинально изменило взгляд на лечение этого заболевания. В будущих исследованиях (например HD19) планируется изучить возможность исключения ХТ или ЛТ из плана лечения больных ЛХ в ранних стадиях благодаря внедрению этого препарата в схемы терапии.

Лечение пациентов с распространенными стадиями ЛХ вызывает наибольшие сложности. Существуют 2 стратегии терапии в этой группе: начало терапии с менее токсичных курсов с последующей поздней интенсификацией или начало терапии с более интенсивных протоколов с последующей деэскалацией в случае достижения положительного ответа. В обоих случаях активно изучают роль ПЭТ и предпринимают попытки включить в лечение брентуксимаб ведотин.

Докладчик представил примеры исследований, в которых изучали обе стратегии. Так, ученые из разных европейских и американских групп инициировали исследования поздней эскалации терапии на основании результатов ПЭТ. Различные исследовательские группы проводят усиление терапии как за счет ЛТ, так и смены ХТ, вплоть до применения ВДХТ с АТГСК. Однако представители GHSG поддерживают стратегию ранней интенсификации лечения, продемонстрировав преимущества этого подхода в нескольких исследованиях. По результатам последнего из них, HD15, в котором сравнивали применение 6 или 8 курсов BEACOPPesc и 8 курсов BEACOPP14, стандартом терапии пациентов с распространенными стадиями ЛХ следует считать 6 курсов BEACOPPesc. Для этой группы больных также проводят большое количество исследований, целью которых является снижение токсичности терапии с повышением ее эффективности. Так, в данное время продолжается набор участников в исследование сравнения эффективности курсов ХТ ABVD и AVD в комбинации с брентуксимаб ведотином; ожидается, что эффективность данной комбинации превысит эффективность ABVD.

Учитывая профиль токсичности курсов BEACOPPesc, ученые также делают попытки снизить ее за счет перехода на менее токсичные курсы (LYSA AHL 2011 Trial), сокращения количества курсов BEACOPPesc (HD18), а также замены цитостатиков на МкАТ (брентуксимаб ведотин).

Таким образом, группа GHSG инициировала рандомизированное исследование для сравнения эффективности и токсичности 6 курсов ХТ BrECAPP и BrECADD. При сопоставлении эффективности указанных курсов ХТ с BEACOPPesc (данные исследования HD18) оказалось, что они не уступают стандартному режиму, а их профиль токсичности значительно лучше. Для получения более объективного сравнения Немецкой кооперативной группой запланировано исследование HD21, в котором

пациенты с распространенными стадиями ЛХ будут рандомизированы для проведения 6 курсов BEACOPPesc или BrECADD.

Профессор Е. Демина привлекла внимание аудитории к еще одной проблеме – лечению анапластической крупноклеточной лимфомы. Это редкое, но достаточно изученное заболевание может протекать в двух формах: системной и кожной. Ключевыми моментами в понимании и лечении этой болезни являются наличие анапластической лимфомной киназы (ALK) и CD30 антигена. К сожалению, несмотря на значительный потенциал в достижении полной ремиссии, по-прежнему сохраняется большое количество рецидивных форм, не разработаны стандарты терапии этого вида лимфомы и существует значительная диссоциация в исходах ALK+ и ALK- случаев. Докладчик напомнил о некоторых клинико-морфологических особенностях течения анапластической крупноклеточной лимфомы. Чаще всего в терапии 1-й линии используют CHOP-подобные курсы ХТ, однако их эффективность достаточно низкая. В случае рецидива заболевания клинические исследования и применение новых препаратов являются опцией выбора для таких пациентов.

Часть доклада профессор Е. Демина посвятила лечению рецидивных и рефрактерных форм ЛХ и анапластической крупноклеточной лимфомы. Сегодня ХТ 1-й линии при ЛХ позволяет получить полный ответ у 72–88% пациентов. Однако у части пациентов отмечают рефрактерное (5–10%) или рецидивное течение болезни (10–30%). В этой группе больных удается достичь полного ответа при проведении 2-й линии терапии с АТГСК только в 61% случаев. Показатели эффективности 3-й линии ХТ значительно ниже, по данным различных исследований, полный ответ регистрируют у 0–17% пациентов, при этом лишь у небольшого количества удается достичь длительной ремиссии. Уровень ответа на сальвадж-терапию перед АТГСК определяет выживаемость пациентов после АТГСК. При этом отсутствие ответа на терапию ассоциировано с неблагоприятным прогнозом для пациента. Также неблагоприятный прогноз связан с рецидивом ЛХ после АТГСК. Опцией для лечения пациентов с рефрактерными и рецидивными формами ЛХ, в случае отсутствия возможности проведения АТГСК, является применение гемцитабина, GVD-схемы (гемцитабин, винорельбин, липосомальный доксорубин), винбластин, среди которых наибольший уровень полного ответа (17%) отмечен для GVD-схемы.

Среди новых препаратов, позволяющих достичь хороших результатов при лечении рефрактерных и рецидивных форм ЛХ после АТГСК или при невозможности ее проведения, Елена Андреевна особо отметила брентуксимаб ведотин, уровень общего ответа на терапию которым составляет 75%, а полного ответа – 34%. Среди побочных реакций III или IV степени отмечали только нейтропению. Также при лечении рефрактерных и рецидивных форм ЛХ после АТГСК или при невозможности ее проведения может быть перспективным применение эверолимуса, леналидомид, MGCD0103, панобиноста, вориноста. Докладчик отметила, что сегодня не существует стандартных руководств для лечения пациентов с рефрактерными и рецидивными формами ЛХ после АТГСК. При этом достижение полного ответа на терапию ЛХ является очень важной задачей, поскольку он ассоциирован с улучшением отдаленных результатов лечения. Получение полного ответа является более про-

блематичным на этапе после проведения АТГСК у пациентов с рефрактерными и рецидивными формами ЛХ. Международные руководства рекомендуют проведение АТГСК при рефрактерных и рецидивных формах заболевания, однако примерно 50% пациентов не достигают длительной ремиссии. Е. Демина проанализировала, какие схемы ХТ являются наиболее эффективными для применения перед АТГСК. Она отметила, что 2 курса DHAP-14 + BEAM сегодня считаются стандартом терапии рефрактерных и рецидивных форм ЛХ.

Профессор Е. Демина в своем докладе уделила внимание тандемной АТГСК, которая показала хороший результат при лечении пациентов с недостаточным ответом на сальвадж-терапию. Однако, несмотря на все успехи в лечении больных ЛХ, все еще остается около 30% пациентов с рефрактерными и рецидивирующими формами, которые умирают от данного заболевания. Это вынуждает исследователей к поиску новых препаратов и схем для улучшения результатов сальвадж-терапии и ВДХТ. Одним из способов повышения эффективности терапии по схеме DHAP может быть ее дополнение новыми препаратами, такими как брентуксимаб ведотин, ритуксимаб, эверолимус, леналидомид и др. Так, в исследовании, проведенном Johnston и соавторами (2010), показано, что применение эверолимуса позволяет добиться сокращения объема опухоли у 89% пациентов с рецидивирующей ЛХ. Основываясь на этих данных, GHSg начала исследование эффективности схемы терапии, включающей эверолимус + DHAP у пациентов с рецидивирующей ЛХ, которое на данный момент еще не завершено.

Также Е. Демина подробно остановилась на новом перспективном препарате – брентуксимабе ведотине, который является конъюгатом антитела к CD30с химиотерапевтическим агентом монометилауристатином Е. Его применение у пациентов с рефрактерными и рецидивирующими формами ЛХ позволяет достичь общего ответа в 75% случаев, при этом полный ответ отмечают у 34% пациентов. У 95% больных регистрируют сокращение объема опухоли. Медиана наступления общего ответа составляет 5,7 недель, а его длительность – 6,7 месяцев. Медиана полного ответа через 12 недель, а его длительность – 20,5 месяцев. Медиана общей выживаемости достигает 22,4 месяцев, при этом общая 1-летняя выживаемость составила 89%. Кроме того, применение брентуксимаба ведотина позволяет статистически достоверно улучшить выживаемость без прогрессирования по сравнению с последней предшествующей системной терапией. Среди наиболее частых побочных эффектов при применении брентуксимаба ведотина отмечают – периферическую сенсорную нейропатию, тошноту, повышенную утомляемость и нейтропению, но исследователи так же говорят о хорошем профиле управляемости побочными эффектами. Профессор отдельно акцентировала внимание на роли брентуксимаба ведотина в повышении эффективности лечения при проведении АТГСК. Далее Е. Демина представила результаты применения брентуксимаба ведотина у пациентов с рефрактерными и рецидивирующими формами ЛХ, у которых не применяли АТГСК, согласно которым общий ответ достигается у 54% больных, а полный ответ – у 22%. При этом среди наиболее частых побочных эффектов докладчик отметила периферическую сенсорную нейропатию и нейтропению.

В завершение своего выступления Елена Андреевна Демина поделилась результатами исследования эффективности применения брентуксимаба ведотина при лечении рецидивной или рефрактерной анапластической крупноклеточной лимфомы. В данном исследовании общего ответа удалось достичь у 86%, а полного — у 57% пациентов. При этом у 97% больных регистрировали уменьшение объема опухоли. Медиана выживаемости без прогрессирования заболевания составила 14,6 мес. Ожидается, что 3-летняя выживаемость по завершении исследования составит 63%. Эти результаты свидетельствуют о том, что брентуксимаб ведотин является перспективным лекарственным средством для лечения больных рефрактерными и рецидивирующими формами ЛХ и анапластической крупноклеточной лимфомой.

Доклад профессора Е. Деминой проиллюстрировали клиническими случаями доктора К.Р. Умарова из Шымкента и Г.У. Хасанова из Астаны. Каждый из случаев комментировали ведущие эксперты патоморфолог и клиницист совместно. Докладчики задали им вопросы, обсудили тактику.

Тему лечения агрессивных лимфом продолжила Гаянэ Сергеевна Тумян д.м.н., доцент кафедры онкологии Российской медицинской академии последипломного образования МЗ РФ, ведущий научный сотрудник отделения химиотерапии гемобластозов РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАН, Россия, которая представила доклад, посвященный лечению неходжкинских лимфом. Вначале докладчик подробно остановилась на лечении группы пациентов пожилого возраста с ДВККЛ. В двух масштабных исследованиях GELA LNH-98.5 и RICOVER-60 подтвержден стандарт терапии по схеме R-CHOP-21. Однако данные GELA LNH 03-6B не показали преимущества интенсификации терапии схемой R-CHOP-14. У пациентов пожилого возраста, у которых проводили лечение по схеме R-CHOP-14, отмечена большая частота развития фебрильной нейтропении (ФН) и других видов токсичности.

Также были приведены интересные данные исследования SEXIE (II фаза) касательно гендерных фармакокинетических особенностей ритуксимаба. Мужчинам вводимая доза ритуксимаба была повышена на треть — до 500 мг/м². Результаты продемонстрировали, что такая доза ритуксимаба позволяет улучшить эффективность терапии данной группы пациентов.

Для профилактики синдрома лизиса опухоли в группе пациентов пожилого возраста Г. Тумян рекомендовала проведение префазы терапии: винкристин 1 мг в/в (7-й день до начала курса ХТ), преднизолон 100 мг/сут per os (7–10-й день). По результатам исследования NHL-B2, удалось улучшить общее состояние пациентов, предотвратить синдром лизиса опухоли, а также усилить эффект терапии после 1-го курса.

Пациентов молодого возраста с ДВККЛ докладчик разделила на 2 группы: низкого и высокого риска. В исследовании MINT для пациентов группы низкого риска преимущество остается за схемой R-CHOP-21 с последующей ЛТ 30–40 Гр (bulky, экстранодальные очаги). Опыт французских коллег в исследовании GELA LNH 03-2B показал улучшение ОВ и выживаемости без прогрессирования при интенсификации терапии по схеме R-ACVBP по сравнению с R-CHOP. Однако гематологическая, неврологическая токсичность, мукозиты возникали чаще в группе пациентов, получавших лечение по схеме R-ACVBP.

Главной стратегией лечения пациентов молодого возраста группы высокого риска является интенсификация ХТ, поэтому изучают роль дальнейшей консолидации с помощью высокодозной ХТ (ВДХТ) и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (АТГСК).

Дискутабельным остается вопрос о проведении промежуточного ПЭТ-КТ у пациентов с ДВККЛ. Однако, следуя рекомендациям конференции в Лугано, для оценки эффективности терапии достаточно проводить ПЭТ-КТ перед началом лечения и после его завершения.

Обсуждая роль ЛТ как консолидации достигнутого ответа после ПХТ, Г. Тумян привела интересные данные исследования М. Pfreundschuh и соавторов (2008). Проведение курса ЛТ на зоны «bulky» после R-CHOP×6 улучшало бессобытийную выживаемость в группе частичного ответа и не добавляло терапевтического преимущества в группе полного ответа. В другом исследовании (Sehn, ASH 2012) оценивали роль ЛТ на область ПЭТ-позитивных остаточных зон. Продemonстрировано, что ЛТ в этом случае позволяет получить результаты лечения, сопоставимые с таковыми в группе пациентов, имевших ПЭТ-негативные результаты. В группе ПЭТ+, в которой ЛТ не проводили, долгосрочные эффекты лечения были существенно хуже. Также докладчик подчеркнула, что снижение дозы ЛТ до 24 Гр при индолентных лимфомах и до 30 Гр при ЛХ не ухудшило ОВ и выживаемость без прогрессирования заболевания. В следующей части своего доклада Гаянэ Сергеевна привела данные о поддерживающей терапии по завершении основной ПХТ при ДВККЛ. Так, она представила данные исследования Jager и соавторов, в котором оценивали проведение поддерживающей терапии ритуксимабом после 4–8 курсов R-CHOP. Однако не показано статистически значимой разницы по сравнению с группой наблюдения. Были представлены данные о роли леналидомида в поддерживающей терапии при рецидиве ДВККЛ. После проведения ПХТ 2-й линии при достижении полного или частичного ответа пациенты получали леналидомид в дозе 25 мг/м². У пациентов, которые получили как минимум 6 курсов (21 или 28 дней) леналидомида, 2-летняя выживаемость без прогрессирования составила 90% (Govi S. et al., 2013).

Обсуждая рецидив ДВККЛ с поражением ЦНС, докладчик отметила, что это редкое (около 5%) позднее осложнение данной лимфомы является фатальным. Пациенты не должны получать профилактику ЦНС-рецидива рутинно ввиду токсичности такой терапии. В эпоху лечения ритуксимабом частота ЦНС-рецидивов несколько снизилась. Все исследования, проведенные для изучения ЦНС-рецидива, были небольшими и не имели адекватной группы сравнения. Метотрексат вводился интратекально и в/в (в высоких дозах). Г. Тумян привела данные (Ferrerì A.J.M., VJN, 2014). Пациентов стратифицировали на группы высокого и низкого риска, в первой группе 40 пациентов получали профилактику, 67 — не получали. Риск оценивали с учетом поражения яичка, позвоночника, основания черепа, грудной железы, почки. Учитывали высокий уровень ЛДГ и стадию III–IV. Профилактику проводили высокодозным метотрексатом в/в и липосомальным цитарабином интратекально (33 пациента) или только интратекальным введением цитарабина, метотрексата и стероидов. ЦНС-рецидив диагностирован у 1 пациента в группе низкого риска, у 8 — в группе высокого риска без профилак-

тики и у 1 – в группе с профилактикой ЦНС-рецидива (в группе интракратальной профилактики). Автор подытожила, что оптимальной является в/в профилактика.

Делая краткий обзор новых таргетных препаратов в лечении ДВККЛ, докладчик рассказал о механизмах действия GA-101, представил дизайн исследования GOYA, в котором пациентов рандомизировали в 2 равных группы – GA-101 и ритуксимаб, обе в сочетании с СНОР. Была показана роль бортезомиба в сочетании с R-СНОР в улучшении результатов терапии пациентов с nonGCB подтипом (Ruan J. et al., JCO 2011). ОБ и выживаемость без прогрессирования заболевания оказались сопоставимыми в этих разнородных группах, добавление бортезомиба нивелирует плохой прогноз для nonGCB подтипа. Также были представлены результаты небольшого исследования применения ингибитора тирозинкиназы Брутона (ВТК) ибрутиниба. Общий ответ у пациентов с ABC (activated B-cell) подтипом составил 41%. Применение леналидомида в монорежиме у пациентов с рецидивом и рефрактерными формами ДВККЛ позволяет достичь общего ответа в 53% случаев при nonGCB-подтипе и всего лишь 8% – при GCB-подтипе (лимфома из В-клеток герминального центра, germinal center B-cell like type – GCB). Несколько исследований посвящено изучению применения R-СНОР в сочетании с леналидомидом (Nowakowski G., 2012; Chiappella A., 2013; Vitolo V., 2014). Применение леналидомида позволило улучшить результаты у пациентов в группе высокого риска IPI (international prognosis index) и nonGCB-подтипа.

Говоря о прогностических факторах ДВККЛ, докладчик подчеркнула значимость IPI и R-IPI индексов, представил результаты нескольких исследований роли подтипа nonGCB/GCB. По данным Visco C. и соавторов (2012), изучение профиля экспрессии генов и иммуногистохимическое исследование по известным алгоритмам имеют эквивалентную прогностическую ценность. Однако Г. Тумян отметила, что нет подтверждения этого в других исследованиях. Также докладчик остановилась на лимфомах серой зоны, имеющих общие черты ДВККЛ и лимфомы Беркитта. При тус+ ДВККЛ ответ на терапию R-СНОР значимо хуже. Лечение больных лимфомой с двумя аномалиями (bcl2+ и тус+) – double-hit лимфомой, группу с наличием которой в исследовании N.A. Johnson (2009) составили 4% пациентов (n=54), продемонстрировало крайне плохие результаты. Медиана ОБ составила 0,26 года против 2,86 при ДВККЛ. Double-hit лимфомы диагностируют, по данным Т.М. Green, методом FISH в 6%, иммуногистохимическим – в 29% случаев. Для лечения bcl2+/тус+-лимфом необходимо применять интенсивные лечебные программы, как при лимфоме Беркитта. Докладчик показала результаты терапии лимфомы Беркитта по схеме CODOX-M/IVAC. В небольших группах (15–40 пациентов) ОБ составляла 77–87%. Итальянский опыт применения данной схемы представлен G. Corazzelli и соавторами, в работе которых показано преимущество данной схемы по сравнению с историческим контролем, а также статистически незначимые различия в лечении лимфомы Беркитта и double-hit лимфомы.

После доклада были рассмотрены клинические случаи, которые представили О. В. Гайнутдинова (Астана), Б. А. Насипов (Алматы), Э.П. Медетбекова (Алматы), Д.Р. Исаметов (Шымкент), О. С.Самойлова (Нижний Новгород).

Второй день ЛимФорума открыли Татьяна Евгеньевна Бялик и Евгений Александрович Никитин с докладами «Последние достижения в области лечения хронического лимфолейкоза» и «Практические аспекты применения таргетной терапии при хроническом лимфолейкозе». Доктора представили доклады, посвященные биологическим лекарственным средствам ингибиторам брутонтитрозинкиназы, в частности осветили на вопросы по их регистрации, эффективности и безопасности при клиническом использовании, остановились на фактах из истории открытия этих препаратов.

В своих докладах Т.Е. Бялик и Е.А. Никитин, описали исторические вехи в изучении патогенеза и лечении хронического лимфолейкоза (ХЛЛ), рассказали о важных аспектах дифференциальной диагностики между ХЛЛ и моноклональным В-клеточным лимфоцитозом, который редко трансформируется в ХЛЛ. На сегодня в зависимости от стадии заболевания по Rai, Binnet пациенты с ХЛЛ имеют различный прогноз выживаемости. Основные симптомы активности заболевания (прогрессирующая лимфаденопатия и спленомегалия, аутоиммунные цитопении и удвоение абсолютного числа лимфоцитов, наличие В-симптомов) остаются неизменными показаниями к началу терапии. Изучена и доказана роль генов TP53, ATM, MYD88, NOTCH1 как неблагоприятных факторов прогноза течения ХЛЛ. Ныне изучают новые прогностические маркеры: SFB3B1, MARK1, ZMYM3, DDX3X, FBXW7. Известно, что в лечении ХЛЛ применяют стероиды, хлорамбуцил, ритуксимаб- и флударабин-содержащие режимы, которые показали свою эффективность во многих клинических исследованиях.

Какие же дальнейшие перспективы и направления развития опций лечения при этой патологии? В настоящее время ведутся многоцентровые исследования по применению разных схем ХТ в зависимости от наличия молекулярно-генетических факторов прогноза. Так, в исследовании CLL8 выявили, что при наличии NOTCH1 эффективность схем RFC и FC нивелируется. Исследуется эффективность таких препаратов, как леналидомид (ОБ 70%), офатумумаб (ОБ 50%) и режим ПХТ FLR у резистентных пациентов. От 7% до 15% больных ХЛЛ рефрактерны к режиму RFC/FC. У таких пациентов следует применять алектумумаб, эффективность которого составляет около 35% уровня общего ответа на терапию, выживаемость без прогрессирования заболевания и общая выживаемость – 6 и 19 месяцев соответственно. Докладчики отметили важную роль алектумумаба в комбинации с дексаметазоном у пациентов с 17del: общий ответ составил около 70%, ОБ – 17–21 мес. Результаты исследования MDACC II фазы (леналидомид + ритуксимаб) у рефрактерных пациентов с ХЛЛ показали высокий уровень общего ответа – 53%, в том числе и у пациентов с 17del хромосомой.

Новыми в лечении ХЛЛ являются группы препаратов, которые влияют на сигнальные пути: ингибиторы тирозинкиназы Брутона (ибрутиниб), ингибитор BCL-2 (навитоклак), ингибиторы NF-κB. Эффективность их применения при ХЛЛ изучается. Возможно, результаты этих и других исследований изменят подходы к лечению ХЛЛ.

Т.Е. Бялик, упоминала в докладе, о лечении пациентов с впервые диагностированной ФЛ, а также лечению больных с рецидивирующими и рефрактерными формами заболевания. ФЛ – это тип неходжкинской лимфомы, который весьма раз-

нообразен по своему течению и выбору тактики терапии. Выделены важные вопросы при инициальном лечении пациентов с ФЛ: начинать терапию или наблюдать и какому методу терапии отдать предпочтение. При выборе оптимальной тактики лечения при данной патологии использованы рекомендации ESMO 2014 года, согласно которым все пациенты делятся на такие группы:

- пациенты с низкой опухолевой нагрузкой, I–II стадия заболевания. В 1-й линии терапии возможно использование тактики Watch and Wait (смотри и жди) или ЛТ на зону поражения;
- II–IV стадия Watch and Wait или ритуксимаб в монорежиме;
- пациенты с высокой опухолевой нагрузкой, III–IV стадия заболевания. Возможная тактика: ритуксимаб + ХТ или ритуксимаб в монорежиме.

Особое внимание профессор уделила тактике Watch and Wait, которая показала свою эффективность в 3 исследованиях, согласно которым медиана до начала лечения первичных пациентов составила 3 года, 20% всех пациентов не нуждаются в лечении в течение 10 лет. Отсутствуют осложнения лечения: токсические ранние и поздние, нарушение фертильности или раннее наступление менопаузы. Данная тактика не повышает вероятность трансформации ФЛ в более агрессивную лимфому.

На основании имеющихся данных, сегодня наиболее эффективными считаются ритуксимабсодержащие режимы ХТ. Согласно данным Walewski и соавторов нет разницы в ОВ у пациентов с ФЛ, которые в качестве 1-й линии терапии получали ПХТ по схеме R-CHOP или R-CVP. Однако пациентам с ФЛ Grade 3 требуется терапия антрациклинсодержащими схемами. Также неплохие результаты демонстрирует комбинация бендамустина с ритуксимабом (BR). Данные рандомизированных клинических исследований показали, что ОВ при сравнении схем BR и R-CHOP не отличается, однако схема BR характеризуется меньшей токсичностью.

Также Т. Бялик уделила большое внимание применению поддерживающей терапии ритуксимабом при лечении пациентов с ФЛ. Доказано, что при применении ритуксимаба в качестве поддерживающей терапии повышается выживаемость без прогрессирования. Вторую часть доклада профессор посвятил диагностике и лечению рецидивных и рефрактерных форм неходжкинской ФЛ. После выявления рецидива пациента необходимо обследовать с обязательным применением биопсии

лимфатического узла или ткани/органа с целью исключения трансформации ФЛ в более агрессивные формы. Выбор терапии должен базироваться на симптомах, связанных с заболеванием, прогрессирующей лимфаденопатии, гепатоспленомегалии, возрасте пациента, наличии сопутствующих заболеваний, проведенном предварительном лечении, чувствительности к терапии и др. Опции лечения схожи с теми, которые применяют для первичных пациентов: Watch and Wait, ритуксимаб + ХТ или ритуксимаб в монорежиме, радиоиммунотерапия, паллиативная ЛТ, ВДХТ с АТГСК, терапия «малыми» молекулами (иделализиб, ибрутиниб). Режимы, содержащие ритуксимаб, значительно улучшают уровень выживаемости без прогрессирования. Открытым остается вопрос о необходимости проведения аллогенной ТГСК у больных с рецидивными и рефрактерными формами.

По уже сложившейся традиции, доклады экспертов были проиллюстрированы клиническими примерами докторов Р.Ф. Вильдановой (Астана), А.А. Клодзинского (Астана), А.С. Джазылтаевой (Алматы), с последующим рецензированием экспертом патоморфологом и клиницистом.

Всего вниманию участников конференции были представлены 10 клинических случаев. Такой необычный формат мероприятия стал «изюминкой» форума. Проведение совместной для гемопатологов и клиницистов секции обсуждения, в рамках которой обсуждали мультидисциплинарный подход к диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний наглядно продемонстрировал, какое количество специалистов разного профиля могут принимать участие в диагностике и лечении пациента. Проведение этой секции и неформальное обсуждение назревших вопросов и проблем позволило найти существенные перспективы для развития взаимодействия между патологами и клиницистами из различных медицинских учреждений. Принято решение о создании платформы, позволяющей средствами телемедицины получить консультативную помощь и ознакомиться с мнением коллег в сложных ситуациях.

Таким образом, в ходе ЛимФорума были рассмотрены новые подходы к диагностике и лечению лимфом. Научно-практический форум с международным участием прошел на высоком профессиональном уровне и стал платформой для обмена опытом между специалистами различных областей медицины — онкологов, гематологов, гемопатологов и специалистов лучевой диагностики и терапии. Проведение мероприятия из года в год позволяет повышать уровень диагностики и лечения лимфопролиферативных заболеваний в Казахстане.